

رأب الإحليل جراحة لإصلاح الجزء الضيق أو الممتد من الإحليل — الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم. يُبطئ هذا التضيق (stricture) تدفق البول أو يوقفه؛ ويُعيد رأب الإحليل فتحه وهو الإصلاح الأكثر ديمومةً وثباتاً. تشرح هذه النشرة كيف تُجرى العملية وكيف تستعد لها وما الذي تتوقعه.

عن هذه العملية

تضيق الإحليل (stricture) هو منطقة متندبة وضيقة في الإحليل تُعسر تفريغ المثانة. على خلاف التوسيع أو الشق البسيط (الذين كثيراً ما يتكرر بعدهما التضيق)، يُعيد رأب الإحليل بناء مجرى البول إلى عرضه الطبيعي — وهو الحل الأكثر موثوقيةً وديمومةً، بمعدل نجاح يبلغ نحو 85-95%. تعتمد طريقة الجراحة على موضع التضيق وطوله:

- قد يُجرى الشق على القضيب أو في المنطقة بين كيس الصفن والشرج (العجان) أو في كليهما، حسب موضع التضيق.
- يمكن استئصال التضيق القصير وخطاطة الطرفين السليمين معاً.
- يُوسّع التضيق الطويل بواسطة طعم — عادةً رقعة من داخل الخد (لهذا الجزء نشرة منفصلة).

سيحدّد جراحك الأسلوب المناسب لتضيقك.

هل هو آمن؟

رأب الإحليل عملية متقنة وعالية الفاعلية؛ تبقى القناة مفتوحة لدى معظم المرضى. كأى جراحة، تحمل مخاطر كالنزيف والعدوى أو عودة التضيق مع الوقت (وغالباً يمكن معالجته). التأثير على الانتصاب أو القذف نادر وعادةً مؤقت.

تعلم المصطلحات

الإحليل

الأنبوب الذي يحمل البول خارج الجسم.

Stricture (تضيق)

منطقة متندبة وضيقة في الإحليل تُبطئ تدفق البول أو تسدّه.

رأب الإحليل

جراحة لإصلاح التضيق وإعادة بناء الإحليل إلى عرضه الطبيعي.

Graft (طعم)

رقعة صغيرة من نسيجك (غالباً من داخل الخد) تُستخدم لتوسيع الإحليل.

العجان

المنطقة بين كيس الصفن والشرج، وهي أحد أماكن الشق الشائعة.

القسطرة

أنبوب لينة يُترك في الإحليل نحو 1-4 أسابيع ريثما يلتئم الإصلاح.

تصوير الإحليل

صورة بالأشعة للإحليل للتحقق من التئام الإصلاح قبل سحب القسطرة.

التخدير العام

دواء يُفنيك نائماً وخالياً من الألم أثناء الجراحة.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام أو النخاعي فلا تشعر بشيء أثناءها. بعد العملية توقّع ألماً وتورماً وكدمات حول موضع الشقّ (القضيب و/أو العجان) لأسابيع قليلة — يُساعد الثلج وحَمالة الصفن ومسكّنات الألم على التخفيف. ستستيقظ وقسطرة في مكانها. تتراوح مدة العملية عادةً بين 2-4 ساعات حسب نوع الإصلاح.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

- تُجرى تحت التخدير العام أو النخاعي — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام وإيقاف بعض الأدوية بما فيها مميّعات الدم).
- يُجرى تحليل البول للكشف عن العدوى — يجب معالجتها أولاً قبل الجراحة.
- لا تدخّن — التدخين يُبطئ الشفاء. إذا كان يُحتمل استخدام طُعْم الخدّ، اعتنِ بقمك وقد يُنصح بتنظيف الأسنان.
- خُطّط لوجود قسطرة بعد العملية (نحو 1-4 أسابيع) ورُتب لمن يأخذك إلى المنزل.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تتناول مميّع دم، أو لديك عدوى في البول أو الجلد حالياً
- أجريت جراحة إحليلية سابقة، أو تلقّيت علاجاً إشعاعياً، أو لديك حالة جلدية كالحرّاز المصلّب

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 أنت في حالة نوم أو خدر من الخصر للأسفل تحت التخدير؛ وتُعطى مضادات حيوية.
- 2 يُجري الجراح شقّاً فوق موضع التضيّق (القضيب أو العجان أو كليهما) ويفتح الجزء المتندّب.
- 3 يُصلّح التضيّق — إمّا باستئصاله وخياطة الطرفين، أو بتوسيعه بواسطة طُعْم.
- 4 تُوضع قسطرة لتصريف البول وحماية الإصلاح ريثما يلتئم؛ ثم تُغلق الشقوق.

بعد الجراحة

- تعود إلى المنزل مع قسطرة، عادةً لمدة 1-4 أسابيع.
- سيُعلّمك فريقك كيف تعتني بها — لا تشدّها.
- التورّم والكدمات وبعض دم في البول حول القسطرة أمر طبيعي في البداية.
- تجنّب الرفع الثقيل والجهد وركوب الدراجة والجنس لأسابيع عدة (نحو 6 أسابيع) حتى يلتئم الإصلاح.
- قبل سحب القسطرة، عادةً ما تُجرى أشعة على الإحليل للتأكد من اكتمال الالتئام.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- القسطرة خرجت أو انسدت أو توقّفت عن التصريف
- حمّى أو قشعريرة، أو احمرار وآلم أو إفرازات متزايدة عند الشقّ
- نزيف شديد، أو عدم القدرة على التبوّل بعد سحب القسطرة

ثلاثة أمور تذكّرها

1. يُعيد رأب الإحليل بناءً مجرى البول المتضيّق وهو الإصلاح الأكثر ديمومة. قد يكون الشقّ على القضيب أو في العجان أو كليهما، وقد يُستخدم طُعْم (غالباً من الخدّ) — سيشرح لك جراحك تفاصيل إصلاحك.
2. للاستعداد: اتّبع تعليمات الصيام والأدوية، وعالج أيّ عدوى أولاً، ولا تدخّن، وخطّط لوجود قسطرة بعد العملية (نحو 1-4 أسابيع).
3. أبقِ القسطرة حتى يسحبها فريقك (عادةً بعد أشعة التحقّق)، وتجنّب الرفع الثقيل والجهد والجنس لأسابيع عدة. اتصل فوراً إذا توقّفت القسطرة عن التصريف أو ارتفعت حرارتك أو لم تستطع التبوّل بعد سحبها.